

LESIONES PIGMENTADAS

Rubén Linares Navarro, Paula Fernández Canga, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La proliferación de melanocitos en la matriz o lecho ungueal provoca una hiperpigmentación del aparato ungueal denominada melanoniquia. Diferenciar si dicha lesión es benigna (Fig. 6) (nevus, lentigo) o maligna (Fig.7) (melanoma lentiginoso acral) puede suponer un reto.

DIAGNÓSTICO

Los signos de alarma que han de hacernos sospechar un melanoma y biopsiar la lesión en pacientes que presenten melanoniquia longitudinal son los siguientes:

- Aparición en la edad adulta.
- Afectación de un solo dedo, especialmente pulgar, índice o primer dedo del pie.
- Melanoniquia longitudinal de más de 3mm de ancho, especialmente si hay ensanchamiento proximal.
- Coloración heterogénea.
- Oscurecimiento o crecimiento de una melanoniquia ya presente.
- Fisuras o distrofia ungueal asociada.
- Pigmentación que se extiende al pliegue ungueal, conocido como signo de Hutchinson.

TRATAMIENTO

En caso de que estos signos no estén presentes, se recomienda monitorización clínica y/o dermatoscópica.



Figura 6: Nevus juncional acral subungueal.



Figura 7: Melanoma lentiginoso acral subungueal.

BIBLIOGRAFÍA

- Tosti A, Piraccini BM, de Farias DC. Dealing with Melanonychia. Semin Cutan Guía del

médico de urgencias Dermatología Med Surg.2009;28(1):49-54.

- Ruben BS. Pigmented Lesions of the Nail Unit: Clinical and Histopathologic Features. Semin Cutan Med Surg.2010;29(3):148-58.
- Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. 8ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2014.